



NOTULEN

HARI / TANGGAL : SENIN, 18 AGUSTUS 2025
PUKUL : 13.00 – SELESAI
JENIS MEETING : RAPAT KOORDINASI KOMITE MEDIK
TEMPAT : LOKASI DINAS MASING – MASING (ZOOM MEETING)

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Pengaturan Kapasitas Layanan Berdasarkan Ketersediaan Jam Praktek Dokter Spesialis Masalah : Untuk DPJP masih terdapat jumlah pasien yang tidak sesuai dengan HFIS BPJS PIC : Kabid Pelayanan Medis Tindak Lanjut : Melakukan penyesuaian jam HFIS dan Jumlah pasien.
2	Pokok Bahasan : Jam kedatangan poli DPJP Masalah : Masih terdapat DPJP yang terlambat datang poli. Angka keterlambatan RS Prima Husada Malang 01.00.12 (lebih dari 60 menit) PIC : Poli dan Kabid Pelayanan Medis Tindak Lanjut : Pengaturan jam praktik DPJP sesuai dengan kedatangan jika masih terlambat.
3	Pokok Bahasan : Jam praktek tenaga medis di Aplikasi HFIS bersifat tetap dan berlaku selama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kontrak kerja antara pihak DPJP dengan faskes. Masalah : DPJP masih ada yang merubah jam HFIS DPJP dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. PIC : Kabid Pelayanan Medis Tindak Lanjut : Dilakukan penyesuaian jam praktik DPJP.
5	Pokok Bahasan : Untuk DPJP yang berhalangan praktik dapat digantikan oleh dokter SMF yang setara dan tidak terdapat jadwal praktik di PHM maupun di Rumah Sakit lain. Masalah: DPJP memiliki kepentingan diluar jadwal praktik. PIC : Kabid Pelayanan Medis dan Poli Tindak Lanjut : Koordinasi dengan keuangan terkait penggajian.
6	Pokok Bahasan : Perubahan jam praktek untuk tenaga medis di Aplikasi HFIS Tindak lanjut : Perubahan jam praktek untuk tenaga medis di Aplikasi HFIS, dikhususkan pada: a. DPJP yang sedang mengikuti kegiatan kedinasan/keagamaan/workshop/tugas belajar/cuti dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) minggu. b. Bagi DPJP yang berhalangan hadir karena sakit/menghadiri kegiatan kedinasan/izin pribadi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu, agar digantikan oleh DPJP lain yang setara dan memiliki SIP di RS Prima Husada Malang / RS Prima Husada Sukorejo / RS Dharma Husada Probolinggo. c. Penambahan DPJP baru. PIC : Kabid Pelayanan Medis dan Poli
7	Pokok Bahasan : Inventarisir HFIS semua DPJP untuk kesiapan data bertemu dengan BPJS Kesehatan (jadwal masih belum diinfokan oleh BPJS, sehingga belum tahu untuk eksekusi HFIS nya kapan) Tindaklanjut : Karena eksekusi jadwal HFIS masih belum pasti dari BPJS kesehatan, maka himbuan RS adalah sesuai dengan jadwal dan kuota yang saat ini berjalan. Dengan adanya sistem pengaturan reservasi yang baru di CSO , IRJA dan IRNA, diharapkan tiap praktek, DPJP tidak sampai kelebihan kuota. PIC : CSO, Kabid Yanmed, IRJA
8	Pokok Bahasan : Pengaturan Kapasitas Layanan Rawat Jalan Untuk Pasien JKN Tindak Lanjut:



	1. Pemberian pelayanan oleh Dokter Spesialis untuk dapat dipertimbangkan minimal 6 - 10 menit per pasien (tanpa tindakan) dan 10-15 menit (dengan tindakan), sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01. 07/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Rangka Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan. 2. Pemberian layanan kepada peserta per hari, mengacu pada jumlah SEP terbit dan jumlah kapasitas sesuai jam layanan poli di Aplikasi HFIS. 3. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelayanan yang melebihi kapasitas, Dokter Spesialis dapat menambah jam praktek terutama pada hari dengan kunjungan pasien yang tinggi (perhitungan waktu layanan mengacu poin B1). Contoh: Dokter Spesialis A memiliki kunjungan rata-rata 60 pasien per praktek, maka jam praktek dapat diatur minimal selama 6 jam. 4. Apabila Dokter Spesialis berhalangan untuk menambah jam praktek, maka pihak manajemen akan a. Mengalihkan pasien kepada DPJP lain dalam 1 SMF yang masih memiliki kapasitas, b. Merekrut Dokter Spesialis baru guna memenuhi kebutuhan kunjungan (apabila didapatkan DPJP tunggal dalam 1 SMF atau jumlah kunjungan masih belum terakomodasi oleh DPJP lain dalam 1 SMF) 5. Pihak manajemen terus berupaya untuk mengatur jumlah kunjungan pasien agar tidak melebihi kapasitas melalui a. Sosialisasi ke masyarakat terkait kapasitas layanan tiap dokter dan melakukan kunjungan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, b. Pencatatan perencanaan reservasi pasien sesuai kapasitas (baik oleh tim IRNA untuk pasien kontrol post KRS, dan tim IRJA untuk pasien kontrol dan rujuk internal per poliklinik), c. Verifikasi jumlah dan penyaringan pasien saat proses pendaftaran. Apabila upaya yang telah dilakukan masih menimbulkan adanya kunjungan melebihi kapasitas, maka pasien dapat diarahkan untuk datang di tanggal yang masih tersedia. Kecuali didapatkan kondisi kegawatan, pasien akan diarahkan ke IGD. PIC : Kabid Pelayanan Medis
9.	Pokok Bahasan : Peran Kepala Unit, MPP dan TIM KMKB dalam Klaim 1. Input, meliputi sumberdaya : SDM, Logistik Medis dan Non Medis Kebijakan : pelayanan JKN dan Keuangan 2. Proses (TPP, RJ, RI, Lba/Rad, Far, OK/VK, Kasir) → verifikasi Proses → DPJP : Clinical, Documentation Improvement) → PNP/PPK/CP/BA 3. Output : Clinica Coding → ICD 10, ICD 9 CM, Kebijakan) 4. Outcome : Clinical Effectivness & Efficiency 5. Klaim RJ/RI : 6. → INA CBG's → Customer Satisfaction Indeks & Status Kesehatan 7. → Provider Satisfaction Indeks : kualitas klaim layak, zero klaim pending dan tidak layak, zero audit paska klaim 8. Alur terlampir : Peran Kepala Unit, MPP dan Tim KMKB <pre>graph LR Input[Input] --> Proses[Proses TPP, RJ, RI, Lab/Rad, Far, OK/VK, Kasir] Proses --> Output[Output] Output --> Outcome[Outcome] Outcome --> Klaim[Klaim RJ/RI] Klaim --> InaCBG[Ina CBGs] InaCBG --> Proses InaCBG --> CS[Customer Satisfaction Indeks & Status Kesehatan] InaCBG --> PS[Provider Satisfaction Indeks]</pre> Sumberdaya: 1. SDM 2. Logistik Medis & Non Medis Kebijakan 1. Pelayanan JKN 2. Keuangan MPP/Tim KMKB Proses (TPP, RJ, RI, Lab/Rad, Far, OK/VK, Kasir) Verifikasi Proses DPJP → Clinical Documentation Improvement PNP/PPK/CP/BA Output Clinical Coding 1. ICD 10 2. ICD 9 CM 3. Kebijakan Outcome Clinical effectiveness & Efficiency Klaim RJ/RI Ina CBGs Provider satisfaction indeks 1. Kualitas klaim layak 2. Zero Klaim Pending dan tidak layak 3. Zero audit paska klaim Customer satisfaction indeks 1. Customer satisfaction indeks 2. Status kesehatan
	PIC : Kabid Yanmed, RI / RJ, Asuransi Center

Pemimpin Rapat
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

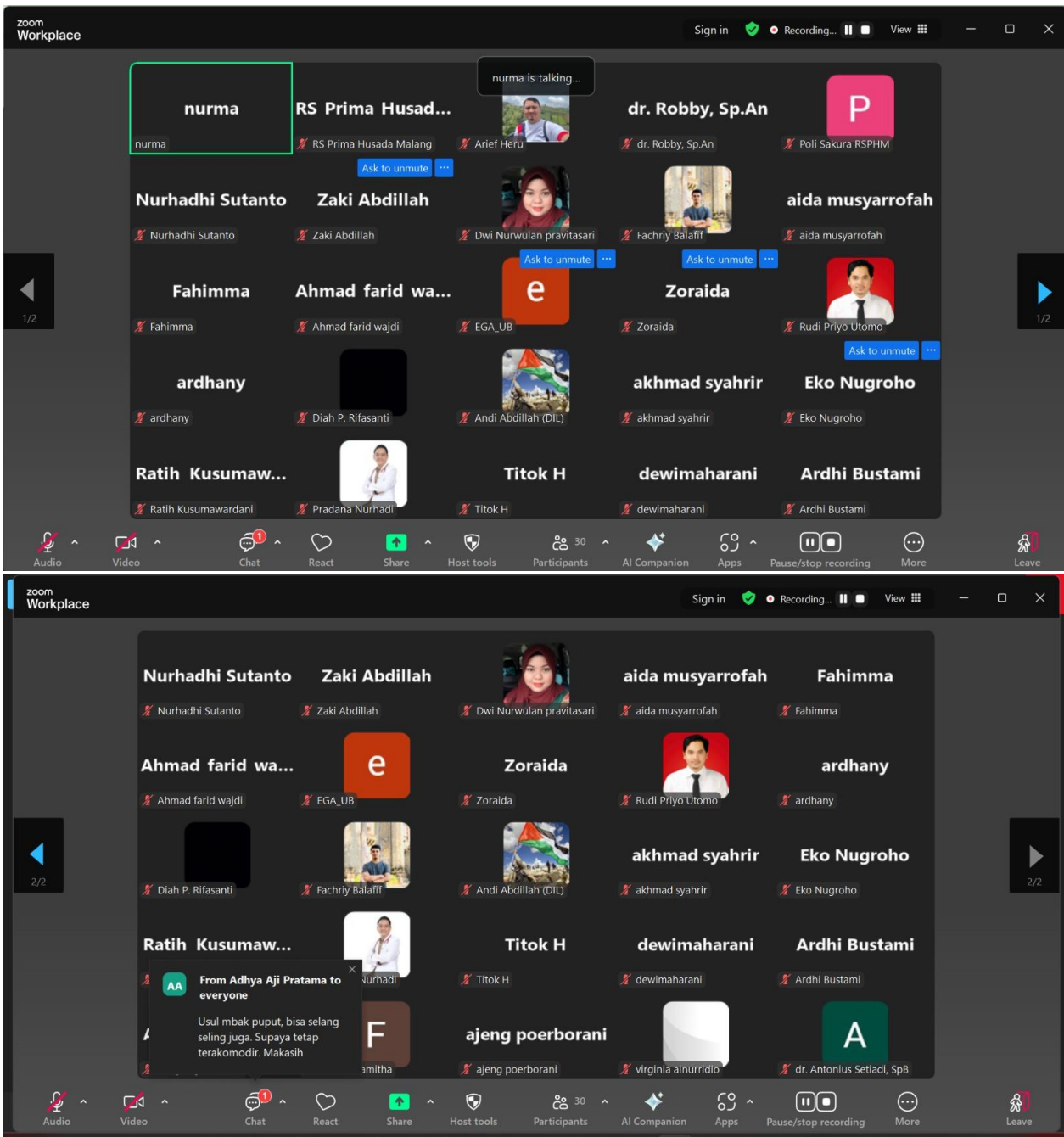
Malang, 18 Agustus 2025
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Fadhila Ayu Setyani, Amd. Kep



DOKUMENTASI





ABSENSI

[002. absensi rapat komdik - HFIS.pdf](#)